

기관경고 및 권고, 통보

1. 제 목 : □□□□ 진료비 수납 관리 부적정

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

♠♠♠♠에서는 국가유공자 및 유가족 입소자의 만성질환 치료 및 건강관리를 위해 「의료법」에 따른 요양기관인 □□□□을 운영하고 있으며, 입소자 외에 복지타운 입주민 및 직원 등 일반진료도 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국민건강보험법」 제44조(비용의 일부부담)에 따르면 요양급여를 받는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 본인일부부담금을 부담하도록 규정하고 있으며, 본인일부부담금의 부담률 및 부담액은 「국민건강보험법 시행령」 제19조 제1항 ‘별표 2’에서 정하고 있습니다.

[표 1] 요양급여비용 본인일부부담율(의원급)

구 분	65세 이상				65세 미만
	요양급여비용 총액	15,000원 이하	15,001원 ~20,000원	20,001원 ~25,000원	25,000원 초과
부담율		1,500원	총액의 10%	총액의 20%	총액의 30%

또한, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제7조(요양급여비용 계산서·영수증의 발급 및 보존)에 따라 요양기관(병원, 의원, 약국 등)은 요양급여를 실시한 때 환자에게 진료비 계산서 및 영수증을 발급해야 합니다.

한편 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제65조제2항(양로지원 등의 위탁)에 따라 양로지원 및 양육지원 비용은 국가가 부담하도록 되어 있으므로,

♠♠♠♠ △△△△ 입소자의 □□□□ 진료비에 대한 본인일부부담금은 ●●●●●에서 지원하는 ♠♠♠♠ 운영비에 포함된 것으로 보아 면제 처리하고 있습니다.

따라서 □□□□에서 환자 본인일부부담금을 수납할 때에는 할인 비율에 따라 정확히 수납하고, 계산서·진료비 영수증을 발급해야 하며, 수납금은 수입 계좌로 정확하게 입금·관리하여 공단에 재정 손실이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

또한 이때, 수납한 본인일부부담금은 공단 「회계규정」 제42조(현금보관의 금지)에 따라 전도금 지급 잔액과 마감 후 수입 현금을 제외한 현금보관을 금지하고 있으므로, 원칙적으로 당일 입금하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

'25년 ○○○○ 종합감사 중 XXXX.XX.XX.~XXXX.XX.XX.까지 □□□□ 본인일부 부담금 수납 업무 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제가 확인되었습니다.

1) 수납금 관리 부적정

□□□□ 진료비 수납은 회계규정에 따라 진료 당일 수납·입금(마감 후 수납 시 익일 입금)해야 함에도 총 XX건, XXXX원을 X일 이상 지연 입금하였으며, 이 중 최대 XX일까지 지연된 사례도 확인하였습니다.

또한, 전산 수납 처리 후 미입금 처리된 XX건(XXXX원)에 대해 소명 받은 결과, XX건(XXXX원)은 공상처리 또는 입소자 등 실제 수납 대상이 아닌 사례로 확인되나, XX건(XXXX원)은 직원 진료 또는 건강생활유지비 착오 미수납으로 당연 수납 대상이지만 수납하지 않은 사례, 전산 수납 처리 후 계좌에는 미입금 상태로 관리되어 소명 불가능한 사례로 확인되었습니다.

공단 「인사규정」 제55조의2에 따른 최근 X년간(XXXX.XX.XX.~XXXX.XX.XX.) 지연 입금은 XX건, XXXX원이며, 본인부담금 수납 대상자의 수납금 미입금은 XX건, XXXX원입니다.

2) 수납 절차 운영 부적정

□□□□에서는 전산시스템(▶▶▶▶)에서 진료비 수납등록 시, 실 수납 여부와 관계없이 모든 진료비를 일괄 수납 처리하였으며, 현금 수납 여부를 별도로 관리하지 않아 전산상 수납 여부를 식별할 수 없는 상태로 운영하였습니다.

또한, 수납대장을 운영하지 않아 현금 수납 이력을 확인할 수 없었으며, 환자에게 영수증을 발급해야 함에도 환자가 요구하지 않았다는 이유로 영수증을 발급하지 않은 채 수납금을 봉투에 넣어 금고가 아닌 개인 3단 서랍(시전장치 있음)에 보관해 왔습니다.

현금은 당일 입금하지 않고 일정 금액이 모이면 일괄 입금하는 방식으로 관리하였으며, 이 과정에서 전산수납액과 현금 수납액 간 상호 대조가 이뤄지지 않았습니다.

미입금액 발생 관련, 수납금의 행방이 소명되지 않아 미입금 환자를 표본 확인한 결과, 환자들은 모두 진료비를 납부했다고 응답하였는데, □□□□은 본인 일부부담금 수납·입금은 정확히 처리했다고 하였습니다.

이러한 현금 수납 구조는 미수금 착오·분실·횡령 가능성이 상존하는데도 ♠♠♠♠에서는 리스크 인식 및 대응이 충분히 이루어지지 못했습니다.

또한, ♠♠♠♠에서는 □□□□의 인적 구조(전문의, 간호사, 간호조무사, 물리치료사, 사회복지사)가 원무, 청구 등 행정업무를 전문으로 하는 직원이 없어, 수납 담당자에 대한 직무 교육, 회계시스템 점검 등을 업무를 지원해주어야 함에도 담당자들에게 업무를 부여한 후 관리·감독을 소홀히 하였고, 장기간 업무 개선이 이루어지지 못한 사실을 확인하였습니다.

3) 미수금 관리 부적정

□□□□은 개원(XXXX.XX.XX.) 이후 약 X년간 ■■■■■ ‘▶▶▶▶’ 프로그램을 사용하면서 실제 수납 여부와 상관없이 모든 진료비를 일괄 현금 수납으로 처리하였습니다.

이로 인해 실제 수납액, 미수금, 100% 할인 대상(△△△△ 입소자)을 구분할 수 없어 미수금 규모를 파악하기 어렵고 환자 등록 정보(주소·연락처 등) 누락으로 미수금 발생 시 회수 조치 등이 사실상 불가능한 상황을 확인하였습니다.

또한, 감사 중 프로그램 매뉴얼을 확인한 결과, 프로그램 내에 미수금·무료 진료 처리, 환자정보 등록·수정 기능이 있음에도 □□□□에서는 이를 활용하거나 관련 교육을 받은 사실이 없었고, 이는 청구결과 및 미수금 보고 누락 등과 함께 □□□□ 행정업무에 대한 기관의 관리·지도 기능이 장기간 작동하지 아니한 것으로 파악됩니다.

4. 관계기관 의견

♠♠♠♠에서는 □□□□ 진료비 수납과 관련하여, 감사실에서 소명 요청한 미입금액 규모가 연평균, 일평균 기준으로 크지 않고, 소액·무료 진료가 많아 일부 미입금은 업무 특성상 발생할 수 있다고 하였습니다.

또한 카드리더기 미비로 진료비를 현금 또는 계좌로 수납했고 직제상 담당 부서가 아님에도 ◆◆◆◆이 장기간 수납업무를 수행해왔으며, 교육·제도 지원 부족을 언급하고, 과거 감사에서 지적되지 않아 이러한 문제를 인지하지 못했다고 하였습니다.

그러나 정확한 수납·대조·입금은 금액 규모와 무관하게 회계의 기본 절차이며, 누락이 반복적으로 발생한 사실은 내부통제 운영이 미흡했던 것으로 판단됩니다.

특히 무료·소액 진료가 많다는 사유로 회계절차의 오류 가능성을 용인하는 것은 회계규정의 취지와 부합하지 않으며, 투명성 확보 측면에서 개선이 필요합니다.

또한, 카드리더기 미비 등 업무 환경은 담당자 과실과 별개로 필수적인 수납 인프라를 장기간 개선하지 않은 기관의 관리 소홀에 해당하고, 직제 미정비, 교육 미실시, 업무지원 부재 등은 기관이 업무 배분·내부통제체계 구축을 장기간 방치한 문제로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■(▷▷▷▷)은

- □□□□ 진료비 수납 관련 관리·감독 소홀로 장기간 회계업무가 투명하게 이루어지지 못하고, 내부통제 체계 구축을 방치한 ♠♠♠♠에 「기관경고」 조치하시기 바랍니다. (기관경고)

○ ♠♠♠♠은

- □□□□ 원무·수납·청구 등 행정업무에 대한 매뉴얼을 마련하여 현장에 적용하고, 현금 수납에 따른 회계 리스크를 사전에 예방할 수 있도록 수납 방식(카드·계좌이체, 영수증 발급 등) 개선 방안을 마련하시기 바라며, (권고)
- 확인된 미입금액에 대하여 실제 수납 여부, 금액의 행방·환수 가능성 등을 재점검하고 그 결과에 따라 적의 조치하시기 바랍니다. (통보)